

PROJETO INTEGRADOR II - ESCOPO

Grupo 1: Angelina Elisa, Ellen Samara, Gabrielle
Caixeta, Ivan Henrique, Julia Amorim da Silva,
Vicente Dei Santi

Campinas, 2026

Sumário

Parte 1 - Os atores e o que cada um faz.....	2
Parte 2 - Os dados que o sistema guarda.....	3
Parte 3 - O Protocolo de Manchester.....	4
Parte 4 - Os estados do atendimento.....	6
Parte 5 - Modelo Conceitual de Entidade e Relacionamento.....	9
Parte 6 - Lacunas.....	11
Parte 7 - Tabela dos entregáveis.....	14
Parte 8 - Viabilidade do projeto.....	16
Passo 1. Quantas semanas.....	16
Passo 2. Horas por semana de cada integrante.....	16
Passo 3. Horas-pessoa disponíveis.....	17
Passo 4. Quanto o escopo custa.....	17
Passo 5. Frase de fecho.....	17
Referências bibliográficas.....	18

Parte 1 - Os atores e o que cada um faz

Ator	Etapa	O que faz no sistema	Regra que existe
Recepção	1. Recepção do atendimento	Cadastrar o paciente com os dados pessoais (nome completo, endereço, RG, CPF, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento etc.) Gerar o número do atendimento (AT0001) Alterar o atendimento * Consultar o atendimento * Cancelar o atendimento *	* Alterar e consultar só valem enquanto o médico não confirmou o atendimento * Cancelar só vale antes da triagem (decisão do grupo, ver Partes 4 e 6)
Enfermagem	2. Triagem do atendimento	Registrar os sinais vitais do paciente (pressão arterial, temperatura corporal, batimentos cardíacos) Registrar a(s) queixa(s) do paciente (dor de cabeça, náusea, enjoo, dor muscular, suor excessivo etc.) Classificar o atendimento segundo o Protocolo de Manchester *	* A classificação de Manchester atribuída aqui é o que ordena a fila que o médico vê na Etapa 3
Médico	3. Atendimento médico	Acessar o atendimento pelo painel (ordenado pela classificação de Manchester) Registrar as medicações administradas Confirmar o atendimento * Dar alta ao paciente *	* Confirmar o atendimento é o gatilho que encerra o direito da Recepção de alterar e consultar aquele registro * Dar alta só vale depois que o atendimento foi confirmado

* ação que tem regra associada (ver coluna "Regra que existe").

Parte 2 - Os dados que o sistema guarda

A lista das informações que o sistema precisa armazenar, agrupadas por assunto.

Assunto	Campos	Por que o sistema precisa disso
Paciente	Nome completo, data de nascimento, CPF, RG, endereço, nome do pai, nome da mãe, telefone	Identificar a pessoa e conseguir encontrá-la de novo numa próxima visita.
Atendimento	Número do atendimento (AT0001) , data e hora de chegada, data e hora de encerramento, situação, paciente, profissional responsável, motivo.	Registrar cada visita do paciente e acompanhar o andamento do atendimento e sua classificação, conforme o protocolo de Manchester.
Triagem	Número da triagem, atendimento, peso, altura, pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca, sintomas relatados, classificação de risco, profissional que realizou a triagem.	Avaliar o estado inicial do paciente e apoiar a priorização dos atendimentos.
Profissional	Código do profissional, nome completo, CPF, especialidade, CRM/registro profissional, telefone	Identificar o responsável pelos atendimentos e registrar suas ações no sistema.
Consulta	Número da consulta/prontuário, atendimento, médico, data e hora, diagnóstico, observações clínicas, procedimentos realizados.	Registrar o histórico clínico e as decisões tomadas durante o atendimento.
Medicação	Código do medicamento, nome do medicamento, dosagem, frequência de uso, quantidade prescrita, consulta relacionada.	Controlar medicamentos prescritos e orientar corretamente o tratamento.
Exames	Código do exame, tipo de	Registrar exames

	exame, data da solicitação, data da realização, resultado, consulta relacionada.	solicitados e seus resultados para apoiar diagnósticos.
Receita Médica	Número da receita, data de emissão, médico responsável, paciente, medicamentos prescritos, validade.	Formalizar a prescrição médica e permitir consultas futuras.

Parte 3 - O Protocolo de Manchester

O que é?

O protocolo de Manchester é um método de classificação que realiza a triagem de pacientes em hospitais baseado na gravidade das condições de saúde e os sintomas apresentados.

Origem

O protocolo de Manchester foi criado em 1994 por um grupo de médicos e enfermeiros. Foi aplicado pela primeira vez no hospital Manchester Royal Infirmary, na cidade de Manchester, em 1997. Desde então, esse método vem sendo adotado por diversos sistemas de saúde ao redor do mundo, devido a sua eficiência.

Por que é utilizado?

O Protocolo de Manchester auxilia na organização e no gerenciamento eficaz dos pacientes que buscam atendimento, e auxilia os médicos a obterem informações importantes sobre a condição do paciente, melhorando a precisão do atendimento. Além de garantir a qualidade do serviço prestado e da segurança do atendimento, fundamentais em qualquer ambiente de saúde.

Como funciona?

Os enfermeiros realizam uma avaliação sobre o quadro clínico em que o paciente se encontra, definem a ordem de prioridade para o atendimento e colocam no paciente uma pulseira com a cor correspondente à gravidade do caso.

A classificação de risco do Protocolo de Manchester é baseada em uma escala de cores que determina a urgência de cada caso. As cores utilizadas são vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Cada uma delas corresponde a um nível específico de urgência que deve ser dado ao paciente:

- **Vermelho: emergência.** O paciente deve ser atendido imediatamente. São os casos em que o paciente apresenta risco de morte.

- **Laranja: muito urgente.** O paciente pode esperar no máximo 10 (dez) minutos para ser atendido. Aqui, o paciente também apresenta risco de morte, embora esteja um pouco mais estável que o anterior.
- **Amarelo: urgente,** no qual a gravidade é moderada. O tempo de espera pode ser de 50 minutos.
- **Verde: pouco urgente,** é indicado para os casos menos graves. O paciente pode esperar até 2 (duas) horas.
- **Azul: não urgente.** É a classificação mais baixa, que envolve problemas simples. Assim, o paciente pode esperar até 4 (quatro) horas.

Painel Médico

A ordenação dos atendimentos deve ser realizada de acordo com a classificação de risco explicada acima.

1. Primeiro, os casos classificados como **emergências**, ou seja, pacientes que recebem uma pulseira **vermelha**, devem ser atendidos **prontamente**.
2. Segundo, os casos classificados como **muito urgentes**, ou seja, pacientes que recebem uma pulseira **laranja**, devem ser atendidos em até **10 minutos**.
3. Terceiro, os casos classificados como **urgentes**, ou seja, pacientes que recebem uma pulseira **amarela**, devem ser atendidos em até **50 minutos**.
4. Quarto, os casos classificados como **pouco urgentes**, ou seja, pacientes que recebem uma pulseira **verde**, devem ser atendidos em até **120 minutos**. Esses pacientes também podem ser encaminhados a outros serviços de saúde.
5. Por último, os casos classificados como **não urgentes**, ou seja, pacientes que recebem uma pulseira **azul**, devem ser atendidos em até **240 minutos**. Esses pacientes também podem ser encaminhados a outros serviços de saúde.

Protocolo de atendimento - HMSF



Imagem 1: Classificação de Risco do Protocolo de Manchester. Fonte: Prefeitura de Teixeira de Freitas. Acesso em 20/09/2026. Disponível em: <<https://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br/prefeitura-informa-sobre-o-protocolo-de-acolhimento-e-classificacao-de-risco-no-hmsf/>>

Parte 4 - Os estados do atendimento

Cada atendimento, identificado pelo número sequencial gerado na recepção (AT0001, AT0002, ...), passa por uma sequência de estados. O estado mostra em que etapa o paciente está e define quais ações cada ator pode fazer naquele momento.

1. Lista dos estados

Estado	O que significa	Ações permitidas sem mudar o estado	Tipo
Aberto	A recepção cadastrou o paciente e gerou o número do atendimento; aguarda a triagem	Recepção: alterar e consultar	Inicial
Triado	A enfermagem registrou sinais vitais, queixas e a classificação de Manchester; o atendimento aparece no painel médico	Recepção: alterar e consultar	Intermediário
Confirmado	O médico registrou as medicações administradas e confirmou o atendimento; o paciente ainda não recebeu alta	Nenhuma — a Recepção perde o direito de alterar e consultar	Intermediário
Cancelado	A recepção cancelou o atendimento antes da triagem	Nenhuma — o registro fica apenas no histórico	Final
Encerrado	O médico deu alta e o paciente saiu do Pronto Socorro	Nenhuma — o registro fica apenas no histórico	Final

2. Diagrama de estados

Diagrama de estados do atendimento

Sistema de Atendimento de Pronto Socorro · Parte 4



3. Tabela de transições

De	Para	Quem dispara	Evento (ação no sistema)	Condição
— (início)	Aberto	Recepção	Cadastrar o paciente	Dados pessoais preenchidos; o sistema gera o

				número do atendimento
Aberto	Cancelado	Recepção	Cancelar o atendimento	O atendimento ainda não foi triado
Aberto	Triado	Enfermagem	Registrar a triagem	Sinais vitais, queixa(s) e classificação de Manchester preenchidos
Triado	Confirmado	Médico	Confirmar o atendimento	Medicações administradas registradas
Confirmado	Encerrado	Médico	Dar alta ao paciente	O atendimento já foi confirmado

4. Transições não permitidas

De	Para	Motivo
Triado	Cancelado	A enfermagem já fez a triagem e o paciente está na fila do painel médico (decisão do grupo)
Confirmado	Cancelado	O médico já atendeu o paciente; a Recepção não pode mais mexer no registro
Triado	Aberto	Não há retorno da triagem para a recepção (decisão do grupo)
Confirmado	Triado	Depois de confirmado, o atendimento não volta para a fila do painel
Cancelado ou Encerrado	Qualquer outro	São estados finais

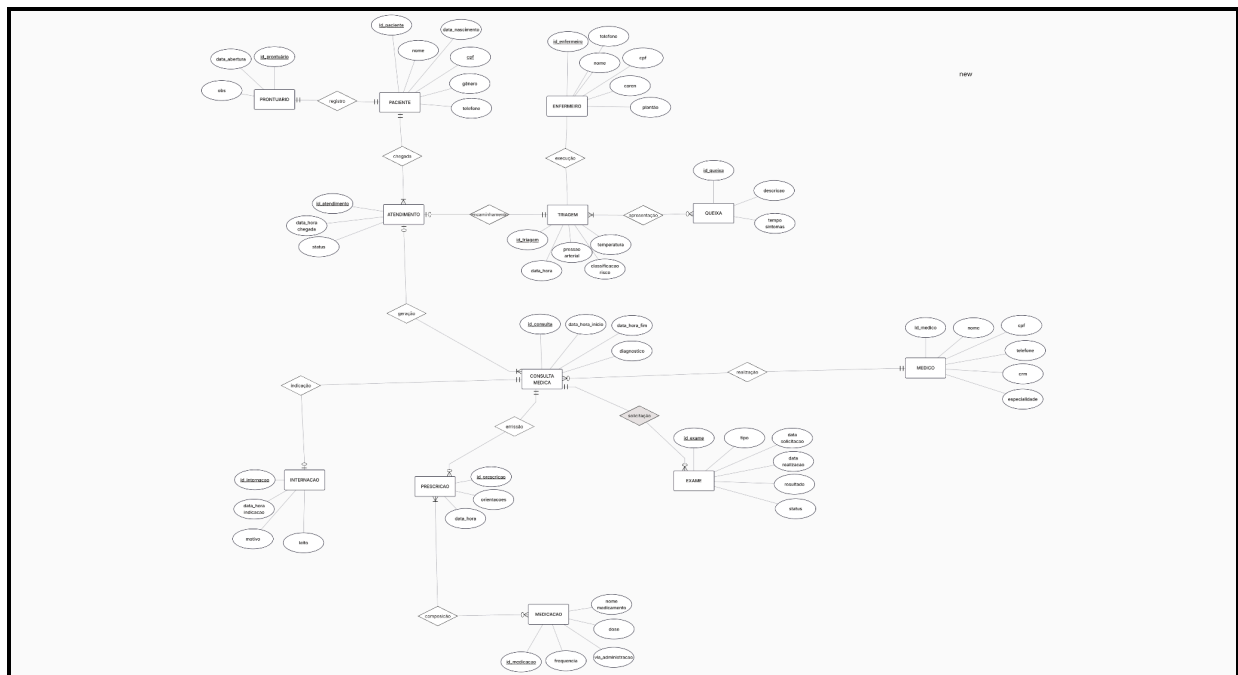
5. Decisões do grupo sobre os estados (levar para a Parte 6)

- **Um atendimento já triado ainda pode ser cancelado?** Não. O cancelamento só é permitido no estado Aberto. Depois que a enfermagem fez a triagem e o paciente entrou na fila do painel médico, cancelar deixa de fazer sentido operacionalmente.
- **Depois que o médico confirma, o atendimento acabou ou falta a alta?** Falta a alta. Confirmado e Encerrado são estados diferentes: a confirmação registra que o médico atendeu e medicou o paciente, mas a saída do Pronto Socorro só acontece com a alta médica, como descreve o objetivo geral do sistema.
- **Um paciente pode voltar da triagem para a recepção?** Não. Não existe transição de volta. Dados cadastrais podem ser corrigidos pela recepção sem mudar o estado.

Regras gerais

- O painel médico mostra apenas atendimentos no estado Triado, ordenados pela classificação de Manchester.
- Alterar os dados cadastrais do paciente não muda o estado do atendimento.

Parte 5 - Modelo Conceitual de Entidade e Relacionamento



MER também disponível no link: [erdplus \(4\).png](#)

Obs: para indicar as cardinalidades, foi utilizado a notação pé de galinha (*crow's foot*) na ferramenta ERDplus.

Algumas regras de negócio que foram mapeadas:

- **Um atendimento tem no máximo uma triagem** — não há re-triagem, mesmo que o quadro do paciente piore na espera (o doc dele questionou isso)

diretamente). Neste caso ele pode passar por um novo atendimento para poder ser atendido mais rapidamente? (a definir)

- **Queixa é tratada como entidade (N:M com Triagem)**, não como campo de texto livre, para permitir múltiplas queixas por triagem e reaproveitamento entre pacientes.
- **Classificação de risco (Protocolo de Manchester) é um atributo dentro de Triagem**, não uma entidade separada.
- **O prontuário é o histórico permanente do paciente (1:1 com Paciente)**, separado dos dados de cada atendimento específico.
- **Internação é opcional e depende de indicação médica na consulta** — nem toda consulta gera internação.

Entidade	Cardinalidade	Entidade	Lido em português
Paciente	1 para N	Atendimento	Um paciente pode ter vários atendimentos ao longo do tempo, e cada atendimento é de um paciente só.
Atendimento	1 para 1	Triagem	Cada atendimento tem no máximo uma triagem, e cada triagem pertence a um atendimento.
Enfermeiro	1 para N	Triagem	Um enfermeiro pode realizar várias triagens, mas cada triagem é feita por um enfermeiro só.
Triagem	N para M	Queixa	Uma triagem pode registrar várias queixas, e uma mesma queixa pode aparecer em várias triagens diferentes.
Atendimento	1 para N	Consulta Médica	Um atendimento pode gerar mais de uma consulta médica, se houver reavaliação, mas cada consulta pertence a um atendimento só.
Médico	1 para N	Consulta Médica	Um médico pode realizar várias consultas, mas cada consulta é feita por um médico só.
Consulta Médica	1 para N	Prescrição	Uma consulta pode gerar no máximo uma prescrição por vez, podendo haver várias ao longo do atendimento, e cada prescrição pertence a uma única consulta.

Prescrição	N para M	Medicação	Uma prescrição pode conter vários medicamentos, e um mesmo medicamento pode estar presente em várias prescrições diferentes.
Consulta Médica	1 para N	Exame	Uma consulta pode solicitar vários exames, mas cada exame pertence a uma única consulta.
Consulta Médica	1 para 1	Internação	Uma consulta pode indicar no máximo uma internação, e cada internação está associada a uma única consulta.
Paciente	1 para 1	Prontuário	Cada paciente possui um único prontuário, que reúne seu histórico permanente.

Parte 6 - Lacunas

A dúvida	Decisão	Motivo
O descritivo não fala em login. Como o sistema sabe se quem está digitando é a recepcionista, a enfermeira ou o médico?	Login por perfil (usuário e senha), com um perfil (recepção, enfermagem ou médico) associado a cada profissional cadastrado.	O sistema precisa saber qual ator está agindo para aplicar as regras da Parte 1 (ex.: só o médico confirma e dá alta, só a enfermagem classifica). Sem login não dá para garantir isso nem para registrar o "profissional responsável" e o "profissional que realizou a triagem" citados na Parte 2.
Paciente que já veio antes: cadastra de novo ou busca pelo CPF?	Busca pelo CPF antes de cadastrar. Se o CPF já existir, reaproveita o cadastro do paciente e apenas abre um novo atendimento (novo número AT).	Evita duplicar pacientes na base e mantém o prontuário como histórico único por paciente (1:1 com Paciente, Parte 5). Cadastrar de novo geraria dois registros para a mesma pessoa e quebraria o histórico.
O objetivo fala em "saída após a alta médica", mas o processo em três etapas termina na confirmação do atendimento. A alta é a mesma coisa que a confirmação?	Não. Confirmado e Encerrado são estados diferentes; a alta é o evento que leva de Confirmado para Encerrado.	Já é uma decisão registrada na Parte 4 (item 5): a confirmação só indica que o médico atendeu e medicou; a saída do Pronto Socorro (objetivo geral do sistema) só ocorre com a alta médica.
O número tem quatro dígitos, o que acontece depois do AT9999, a contagem reinicia a cada ano?	Sim, a contagem reinicia a cada ano (ex.: AT0001/2026, AT0001/2027) ou passa a incluir o ano no número.	Quatro dígitos permitem só até 9999 atendimentos; um pronto-socorro pode superar isso em um ano. Reiniciar por ano evita estourar o formato

		sem precisar redesenhar o campo.
O cadastro exige RG e CPF, mas chega paciente inconsciente ou sem documento. O cadastro trava?	O cadastro não trava: permite salvar como "paciente não identificado", com RG/CPF em branco, e completa os dados depois.	Em uma emergência a prioridade é atender, não documentar. Exigir RG/CPF sempre impediria abrir o atendimento de um paciente inconsciente, o que vai contra o objetivo do pronto-socorro.
O cadastro pede nome do pai e da mãe, o que indica paciente menor, mas não pede acompanhante.	Não pede acompanhante nesta versão do escopo; fica registrado como lacuna para uma futura evolução do sistema.	O grupo optou por não expandir o cadastro além do que o descritivo pede, para manter o escopo do projeto controlado; a ausência do campo é reconhecida, mas não corrigida agora.
O paciente vai embora antes de ser chamado. O atendimento fica Triado para sempre?	Sim, o atendimento fica Triado indefinidamente, pois não existe uma transição de "Triado" para um estado de saída sem confirmação médica.	A tabela de estados (Parte 4) só prevê Confirmado e Encerrado como próximos estados de Triado, os dois disparados pelo médico. Criar uma transição nova mudaria o modelo já fechado nas Partes 4 e 5.
A enfermagem classifica segundo Manchester. A enfermeira escolhe a cor, ou o sistema calcula pelos sinais vitais?	A enfermeira escolhe a cor manualmente, com base nos sinais vitais e queixas que ela mesma registrou.	O sistema não tem regras de negócio suficientes (limiares clínicos) descritas no descritivo para calcular a cor automaticamente; delegar a decisão à enfermeira é mais simples e é assim que o Protocolo de Manchester funciona na prática.
O paciente piora enquanto espera, e a Parte 5 decidiu que não há retriagem. O que acontece?	Nada muda no sistema: como decidido na Parte 5, não há retriagem, então o atendimento permanece Triado com a classificação original até ser chamado pelo médico.	Foi uma decisão explícita do grupo (Parte 5) não modelar a retriagem, para simplificar o escopo do projeto; o agravamento do quadro fica fora do controle automatizado do sistema.
O painel não mostra hora de chegada, e é ela que desempata dois pacientes da mesma cor.	A hora de chegada (data e hora de chegada do atendimento, já prevista na Parte 2) é usada como critério de desempate entre pacientes da mesma cor.	O campo já existe no modelo de dados (Parte 2); usá-lo como desempate resolve a lacuna sem precisar criar nenhuma informação nova.
O painel atualiza sozinho quando a enfermagem classifica alguém, ou o médico precisa recarregar?	O painel atualiza automaticamente assim que a enfermagem confirma uma triagem, sem exigir recarregamento manual pelo médico.	Um painel que exige atualização manual atrasaria o atendimento de casos graves; atualização automática é coerente com a função do painel de ordenar a fila em

		tempo real (Parte 1 e Parte 4).
Vários médicos usam o painel ao mesmo tempo. Dois podem chamar o mesmo paciente?	Não. Ao abrir/chamar um atendimento, o sistema trava aquele registro para o médico que o acessou primeiro, impedindo que outro médico o chame ao mesmo tempo.	Sem essa trava, dois médicos poderiam confirmar o mesmo atendimento, gerando dados conflitantes de medicação e diagnóstico para o mesmo paciente.
Pressão, temperatura e frequência cardíaca são texto livre ou número com faixa válida?	São números com faixa válida (ex.: pressão em mmHg, temperatura em °C, frequência cardíaca em bpm), não texto livre.	Campos numéricos com faixa evitam erros de digitação e são necessários caso o sistema venha a usar esses valores para apoiar a classificação de risco (Parte 3).
O painel mostra nome, nascimento e classificação, mas não a queixa nem os sinais vitais. O médico escolhe sabendo só a cor?	O médico vê a queixa e os sinais vitais, além da cor, nos detalhes do atendimento ao abri-lo, não apenas no card resumido do painel.	Atender apenas pela cor tiraria informação clínica essencial do médico; a Triagem já guarda esses dados (Parte 2), então basta exibi-los na tela de detalhe do atendimento.
A enfermagem tem tela de triagem, mas não tem fila. Como ela sabe quem chegou e ainda não foi triado?	A enfermagem tem uma fila de atendimentos no estado Aberto (aguardando triagem), semelhante ao painel do médico.	Sem essa fila a enfermagem não teria como saber quem chegou e ainda não foi chamado; o mesmo padrão do painel médico (Parte 4) se aplica à etapa de triagem.
O slide 11 pergunta onde a regra da trava vai morar no botão da tela, no back-end ou no banco de dados?	A regra fica no back-end (na lógica da aplicação/servidor), não apenas no botão da tela.	Colocar a regra só no botão permitiria contornar a trava chamando a ação por outro caminho; validar no back-end garante a regra mesmo se a tela for manipulada.
A enfermagem tem tela de triagem, mas não tem lista. Como a enfermeira sabe quem chegou e ainda não foi triado?	Mesma decisão da pergunta 15: a enfermagem tem uma fila de atendimentos Abertos aguardando triagem.	Pergunta duplicada da anterior; mantém-se a mesma resposta para preservar a consistência do documento.
O descritivo pergunta onde a regra da trava vai morar: no botão da tela, no back-end ou no banco de dados?	Mesma decisão da pergunta 16: a regra fica no back-end.	Pergunta duplicada da anterior; mantém-se a mesma resposta para preservar a consistência do documento.
A classificação aparece só como cor. E um médico com daltonismo?	A cor vem acompanhada do nome da classificação por extenso (ex.: "Vermelho — Emergência"), não só da cor.	Depender só da cor exclui usuários com daltonismo; adicionar o texto resolve o problema sem mudar o modelo de dados, que já guarda a classificação como atributo de texto (Parte 5).
Paciente cadastrado como não identificado que depois é identificado: cria um cadastro novo ou completa o que	Completa o cadastro existente do paciente não identificado com os dados agora conhecidos, em vez de criar	Criar um cadastro novo duplicaria o paciente e separaria o histórico anterior (atendimento, triagem) do

existe?	um novo registro.	prontuário correto; completar preserva a integridade do histórico único por paciente.
O paciente já tem um atendimento em aberto e chega de novo. O sistema aceita dois abertos ao mesmo tempo?	Não. O sistema não permite abrir um novo atendimento enquanto o paciente já tiver um atendimento em aberto (Aberto, Triado ou Confirmado).	Permitir dois atendimentos simultâneos criaria ambiguidade sobre qual triagem, classificação e consulta pertence a qual visita do mesmo paciente.
Os três perfis mexem no mesmo atendimento. A recepção pode alterar os dados enquanto a enfermagem está triando?	Sim. Enquanto o atendimento está em Aberto ou Triado, a recepção pode alterar os dados cadastrais mesmo com a triagem em andamento.	A Parte 1 já estabelece que a recepção só perde o direito de alterar e consultar quando o médico confirma o atendimento; a triagem em si não bloqueia a recepção.
A partir do atendimento do médico, fala que os 3 botões ficam bloqueados, até mesmo o botão de consulta fica? A recepção não pode mexer em um cadastro de um paciente sendo atendido?	Sim, os três botões da etapa médica ficam bloqueados após a confirmação, e a recepção não pode mais alterar o cadastro do paciente sendo atendido.	Isso é a mesma regra já definida na Parte 1 e na Parte 4: confirmar o atendimento encerra o direito de alterar/consultar da recepção, então bloquear tudo depois da confirmação mantém a consistência do registro.
O descritivo prevê três perfis, mas nenhuma tela cadastra os profissionais. Quem cria o acesso da recepcionista, da enfermeira e do médico?	É a própria recepção, com um cadastro simplificado de profissionais (nome, CPF, especialidade/perfil) feito por ela mesma ou por um administrador do sistema.	O descritivo não define uma tela específica para isso, mas o sistema precisa de algum cadastro de profissionais para vincular o login e o "profissional responsável" citados na Parte 1 e na Parte 2.
Dois pacientes classificados na mesma cor, esperando ao mesmo tempo. Qual dos dois o painel mostra primeiro?	Desempate pela hora de chegada, do mesmo jeito que na pergunta 10: quem chegou primeiro aparece primeiro no painel.	Reaproveita a mesma regra de desempate já definida (campo de data e hora de chegada da Parte 2), garantindo uma ordem justa e sem depender de um critério novo.

Parte 7 - Tabela dos entregáveis

ID	Entregável	Feito quando	Parte	Ator	Tam.
E1	Cadastro de paciente e geração do número de atendimento	O sistema permite cadastrar os dados pessoais do paciente e gera automaticamente um	Front	Recepção	M

		número de atendimento, como AT0001.			
E2	Alteração dos dados do atendimento	A recepção consegue alterar os dados enquanto o atendimento ainda não foi confirmado pelo médico.	Front	Recepção	M
E3	Consulta do atendimento	A recepção consegue consultar os dados do atendimento enquanto tiver permissão para isso.	Front	Recepção	P
E4	Cancelamento do atendimento	A recepção consegue cancelar um atendimento somente antes da realização da triagem.	Front	Recepção	P
E5	Registro da triagem	O sistema permite registrar sinais vitais, queixas e classificação de risco do paciente.	Front	Enfermagem	G
E6	Classificação de risco pelo Protocolo de Manchester	O atendimento recebe uma classificação entre vermelho, laranja, amarelo, verde ou azul, que determina sua prioridade.	Back	Enfermagem	G

E7	Painel médico de atendimentos	O painel apresenta os atendimentos triados organizados conforme a classificação de Manchester.	Front	Médico	G
E8	Registro do atendimento médico	O médico consegue acessar o atendimento e registrar as informações do atendimento realizado, incluindo as medicações administradas.	Front	Médico	G
E9	Confirmação do atendimento	Ao confirmar o atendimento, o sistema registra a confirmação e impede novas alterações ou consultas pela recepção.	Back	Médico	M
E10	Alta do paciente	O médico consegue dar alta somente depois que o atendimento foi confirmado, encerrando o atendimento.	Front	Médico	P
E11	Controle dos estados do atendimento	O sistema controla corretamente os estados Aberto, Triado, Confirmado, Cancelado e	Back	Sistema	G

		Encerrado, permitindo somente as transições previstas.			
--	--	--	--	--	--

Parte 8 - Viabilidade do projeto

Passo 1. Quantas semanas

Prazo para entrega: dia **09/12/2026**.

Data de início do desenvolvimento: **30/09/2026**.

Tempo total para desenvolvimento: 11 semanas.

Passo 2. Horas por semana de cada integrante

Integrante	Horas por semana
Angelina	5 horas
Ellen	2 horas
Gabrielle	3 horas
Ivan	3 horas
Julia	3 horas
Vicente	3 horas
Total do grupo, por semana	19 horas

Passo 3. Horas-pessoa disponíveis

19 horas por semana x 11 semanas = 209 horas.

Passo 4. Quanto o escopo custa

* Considerando que $P=8$; $M=20$ e $G=40$.

Tamanho	Quantos itens	Horas
P (8h)	3	24

M (20h)	3	60
G (40h)	5	200
Total	11 itens	284 horas

Passo 5. Frase de fecho

Temos **209** horas-pessoa e o escopo pede **284**. **Não cabe**. A ordem de ataque é E1, E5, E6, E7 e E8 (sistema de cadastro na recepção, banco de dados e triagem, pois esses elementos possibilitam o atendimento) e revisamos a conta na reunião de outubro.

Parte 9 - Onde está tudo

Repositório

<https://github.com/PI2-SI-2026-Pronto-Socorro/pi2-2026-2-0102-grupo01>

Integrantes

Angelina Elisa — @AngelinaBueno
 Ellen Samara — @aellenb
 Gabrielle Caixeta — @caixetss
 Ivan Henrique — @lwanhrq
 Julia Amorim da Silva — @julia-amorim-silva
 Vicente Dei Santi — @VicenteDeiSanti

Referências bibliográficas

CAJATI, Prefeitura. **Pronto Atendimento implementa a pulseira do Protocolo Manchester e otimiza a triagem no atendimento da instituição de emergência no Município.** Disponível em:

<<https://www.cajati.sp.gov.br/noticia/print-noticia/4990/pronto-atendimento-implementa-a-pulseira-do-protocolo-manchester-e-otimiza-a-triagem-no-atendimento-da-instituicao-de-emergencia-no-municipio/>>. Acesso em: 20 Set. 2026.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. Disponível em:

<<https://cdr.saude.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/08/CLASSIFICACAO-DE-RISCO-12.8.22.pdf>>. Acesso em: 20 Set. 2026.

FERREIRA, Brian. **Prefeitura informa sobre o protocolo de acolhimento e classificação de risco no HMSF.** Prefeitura de Teixeira de Freitas - Bahia. Disponível em:

<<https://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br/prefeitura-informa-sobre-o-protocolo-de-acolhimento-e-classificacao-de-risco-no-hmsf/>>. Acesso em: 20 Set. 2026.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1.** [S. l.]: OMG, 2017. Disponível em: <<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>>. Acesso em: 22 Set. 2026.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS. **Projeto Integrador II: Descritivo do Escopo do Projeto – Sistema de Atendimento de Pronto Socorro.** Campinas: PUC-Campinas, 2026. Material didático da disciplina.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS. **Projeto Integrador II: Entrega 1 – Entendimento do Escopo (PI2026-2).** Campinas: PUC-Campinas, 2026. Material didático da disciplina.